DISCIPLINA: Resgate Pré-Hospitalar – EAC CBMGO (EAD)

EMENTA

Apresentar aos discentes do Estágio de Adaptação de Cabos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás uma atualização profissional em Resgate Pré-Hospitalar, contemplando os fundamentos científicos, operacionais e doutrinários da Restrição de Movimento da Coluna (RMC), das emergências psiquiátricas no Atendimento Pré-Hospitalar e Atendimento em áreas remotas. A disciplina aborda protocolos institucionais do CBMGO, recomendações internacionais, análise de riscos e benefícios, uso racional de dispositivos e tomada de decisão em cenários operacionais, estruturada para a modalidade de Ensino a Distância (EAD).

APRESENTAÇÃO

Esta apostila foi elaborada para subsidiar o processo de ensino-aprendizagem na modalidade EAD do Estágio de Adaptação de Cabos do CBMGO, permitindo ao aluno estudar de forma autônoma, progressiva e fundamentada. O material foi estruturado em temas e lições, respeitando a sequência lógica do conteúdo e possibilitando a assimilação gradual dos conceitos, princípios e práticas do Atendimento Pré-Hospitalar.

O conteúdo não possui caráter resumido ou superficial, sendo desenvolvido a partir de protocolos institucionais do CBMGO, diretrizes internacionais consagradas (PHTLS, ITLS e consensos europeus) e experiências operacionais. APH em áreas remotas. Também são abordados princípios de avaliação, abordagem e manejo de emergências psiquiátricas no ambiente pré-hospitalar, considerando a segurança da equipe, a comunicação com o paciente e a tomada de decisão em situações de agitação psicomotora e risco comportamental.

O objetivo é preparar o militar para atuar com segurança técnica, capacidade de avaliação e tomada de decisão no atendimento pré-hospitalar, contribuindo para a eficiência das operações e para a proteção da vida.

OBJETIVOS GERAIS

Atualizar e fortalecer os conhecimentos dos militares do CBMGO em Atendimento Pré-Hospitalar.

Capacitar o militar a aplicar corretamente a Restrição de Movimento da Coluna com base em evidências científicas.

Compreender princípios de abordagem e manejo de emergências psiquiátricas no contexto do Atendimento Pré-Hospitalar.

Fortalecer a tomada de decisão em cenários operacionais, considerando riscos, benefícios e segurança da equipe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender a evolução dos protocolos de Atendimento Pré-Hospitalar no CBMGO.

Diferenciar princípios e preferências no atendimento ao trauma.

Reconhecer indicações, contraindicações e limitações da Restrição de Movimento da Coluna.

Aplicar corretamente os dispositivos de transporte e extricação disponíveis.

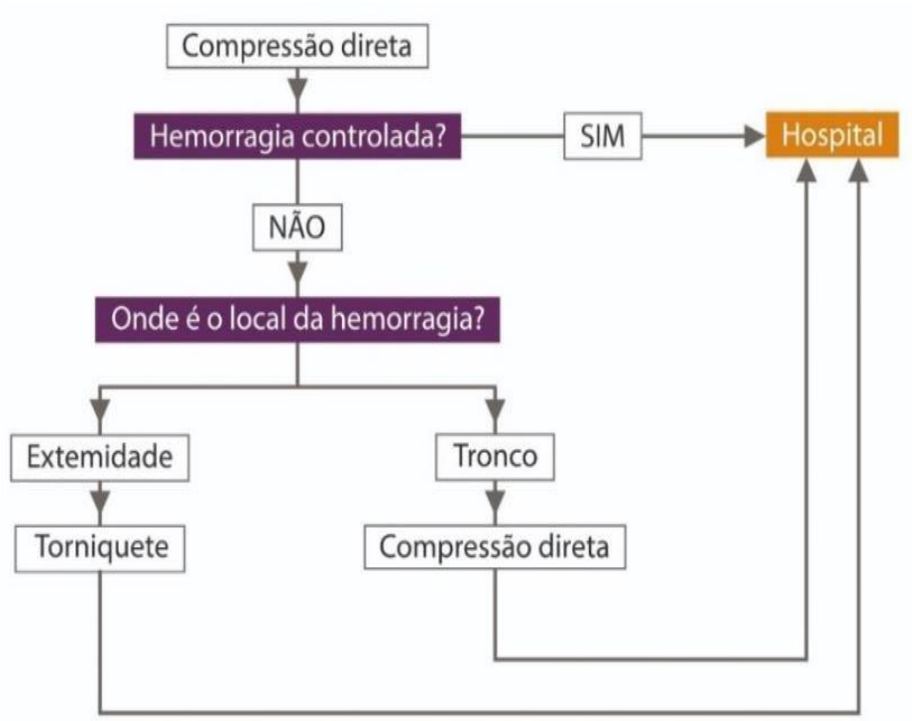
Compreender fundamentos de avaliação, abordagem e manejo inicial de pacientes em emergência psiquiátrica no ambiente pré-hospitalar.

TEMA I – ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

APRESENTAÇÃO DO TEMA O Atendimento Pré-Hospitalar encontra-se em constante evolução, impulsionado por evidências científicas, estudos biomecânicos, análise de desfechos clínicos e revisões de protocolos internacionais. O CBMGO, atento a essas mudanças, atualizou seus protocolos ao longo dos anos, culminando no Protocolo SBV 2020, que adota conceitos como XABCDE, RMC seletiva, uso racional de dispositivos e priorização do transporte rápido.

LIÇÃO 01 – OBJETIVO: O objetivo primário da atualização profissional em APH é instruir o militar sobre a existência e a importância das recomendações internacionais, sem perder de vista que a conduta deve ser baseada prioritariamente no protocolo institucional do CBMGO. A atualização visa alinhar a prática operacional à melhor evidência disponível, garantindo maior segurança à vítima e à equipe.

LIÇÃO 02 – XABCDE E CONTROLE DE HEMORRAGIAS A abordagem XABCDE prioriza o controle imediato das hemorragias exsanguinantes, reconhecendo que o sangramento maciço pode levar o paciente à morte em poucos minutos. Conforme o PHTLS 9ª edição, o controle da hemorragia deve preceder inclusive a avaliação da via aérea. O fluxo de hemostasia inicia-se com compressão direta, sem remoção de curativos saturados, evoluindo para o uso de torniquete em lesões de extremidades, respeitando o tempo máximo recomendado.



LIÇÃO 03 – PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA E RCP O Protocolo CBMGO 2020 padroniza a RCP em ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, com ritmo de 100 a 120 compressões por minuto e checagem de pulso a cada 2 minutos. No afogamento, a conduta difere, com início das ventilações com cinco insuflações utilizando AMBU com reservatório de oxigênio.

LIÇÃO 04 - OXIGENOTERAPIA NO APH A oxigenoterapia é um recurso fundamental no suporte básico de vida, devendo ser aplicada de forma racional, conforme a condição clínica da vítima. O uso indiscriminado pode não trazer benefícios e, em alguns casos, gerar efeitos adversos.

VPM - ADULTO	CLASSIFICAÇÃO	CUIDADO GERAL COM A VÍTIMA (CONDUTA)
AUSENTE	APNÉICO	SEGUIR CONDUTA PARADA RESPIRATÓRIA
< 12	BRADPNÉICO	ADMINISTRE O_2 A 100% COM AMBU E RESERVATÓRIO (15 L/MIN),
ENTRE 12 E 20	EUPNÉIA	CONSIDERE UTILIZAR OXIGÊNIO VIA CATETER NASAL (4 A 6 L/MIN)
ENTRE 20 E 30	TAQUIPNÉIA	ADMINISTRE OXIGÊNIO VIA MÁSCARA COM VÁLVULA COM RESERVATÓRIO OU MÁSCARA NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO (10 A 15 L/MIN).
>30	TAQUIPNÉIA SEVERA	ADMINISTRE O_2 A 100% COM AMBU E RESERVATÓRIO (15 L/MIN).

3.6.3 ASSISTÊNCIA QUANTO À SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO:

CONDUTA A SER ADOTADA PARA OFERTADO DE OXIGÊNIO À VÍTIMA		
Saturação de O_2	**Classificação**	**Cuidado geral com a vítima (conduta)**
> 94%	Normal	Administre oxigênio via cateter nasal (4 a 6 L/min) ou máscara (12 a 15 L/min), se necessário.
< 94% e >90%	Hipóxia "Leve"	Administre oxigênio via máscara 12 a 15 L/min.
≤ 90%	Hipóxia Significativa	Administre O_2 a 100% com AMBU e reservatório (15 L/min), seguir conduta parada respiratória.
≤ 85%	Hipóxia Severa "Grave"	Administre O_2 a 100% com AMBU e reservatório (15 L/min), seguir conduta parada respiratória (atenção para risco PCR).

ATENÇÃO!!!!

✓ Alteração na saturação da vítima, ofertar inicialmente oxigênio via máscara não reinalante. Caso não tenha uma resposta satisfatória de melhora, iniciar a ventilação com AMBU e reservatório de O_2.

3.6.4 PARÂMETROS DO PERCENTUAL DE OXIGÊNIO:

Dispositivo	Régua de fluxo*	Concentração O_2*
SEM OXIGÊNIO SUPLEMENTAR		
Ventilação boca-boca	N/A	15 a 16 %
Ventilação Boca-máscara	N/A	15 a 16 %
Ventilação AMBU	N/A	21 %
COM OXIGÊNIO SUPLEMENTAR		
Ventilação - Cânula nasal	1-6 l	24-45%
Boca-máscara	10 l	50%
Máscara facial simples	8-10 l	40-60%
Ventilação AMBU s/reservatório	8-10 l	40-60%
Ventilação AMBU c/reservatório	10-15 l	90-100%
Válvula de demanda	N/A	90-100%
Ventilador	N/A	21-100%

*litros por minutos (L/min), as porcentagens são valores aproximados, N/A - não se aplica.

TEMA II – RESTRIÇÃO DE MOVIMENTO DA COLUNA (RMC)

APRESENTAÇÃO DO TEMA A Restrição de Movimento da Coluna substitui o conceito tradicional de imobilização universal, adotando uma abordagem seletiva baseada em avaliação clínica, mecanismo de trauma e evidências científicas. O foco deixa de ser a rigidez absoluta e passa a ser a minimização de movimentos potencialmente lesivos.

LIÇÃO 05 – FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DA RMC Protocolos como NEXUS e CCR demonstraram que a maioria das vítimas submetidas à radiografia cervical não apresentava lesões significativas, evidenciando o excesso de intervenções. Esses estudos influenciaram diretamente a prática pré-hospitalar moderna.

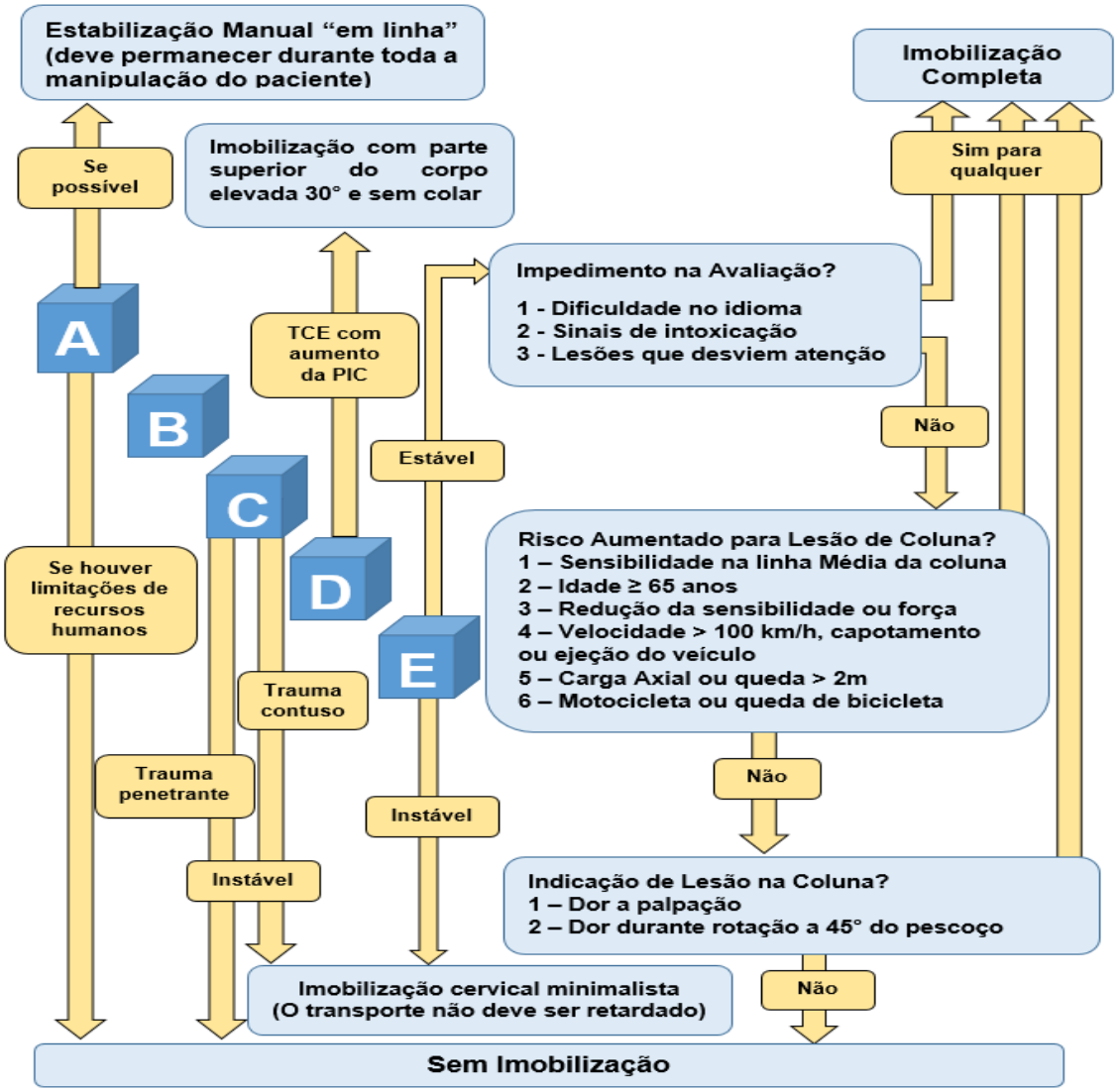
LIÇÃO 06 – **Princípio** – fundamento básico científico ou baseado em evidências para melhora do paciente ou a sua sobrevida. São imutáveis e universais. **Preferência** – a maneira como o profissional de atendimento pre- hospitalar alcança o princípio. Ex: manejo da via aérea, controle da hemorragia. A **preferência** usada para alcançar o princípio depende de vários fatores: situação existente, Condição do paciente, Base de conhecimentos, habilidades e experiência do profissional de atendimento pré-hospitalar, Protocolos locais e Equipamentos disponíveis

LIÇÃO 07 – POSSIBILIDADES DE CONDUTA EM RMC O profissional pode optar por restrição completa, restrição minimalista ou não restrição. Em traumas penetrantes sem sinais neurológicos, a não restrição é recomendada, priorizando transporte imediato. GUIDELINES E PROTOCOLO CBMGO O CBMGO adota diretrizes internacionais, incluindo guideline alemão (MARSHAL), norueguês, sul-africano, britânico, ITLS e PHTLS, consolidadas no Protocolo SBV 2020.

NÃO RESTRINGIR

RESTRIÇÃO COMPLETA

RESTRIÇÃO MINIMALISTA



TEMA III – DISPOSITIVOS E TÉCNICAS DE RMC

APRESENTAÇÃO DO TEMA Os dispositivos utilizados no APH devem ser entendidos prioritariamente como meios de transporte, e não de tratamento, sendo escolhidos conforme estabilidade hemodinâmica, tempo de transporte e segurança.

LIÇÃO 09 – PRANCHA SCOOP A prancha scoop permite a remoção da vítima sem rolamento, reduzindo a movimentação da coluna. É mais confortável que a prancha rígida e indicada para remoções e transferências, com restrições quanto ao tempo de uso e hipotermia.

LIÇÃO 10 – MACA A VÁCUO A maca a vácuo é amplamente recomendada para vítimas estáveis, oferecendo conforto, suporte anatômico e menor risco de lesões por pressão.

LIÇÃO 11 – MACA DA AMBULÂNCIA A própria maca da ambulância é um excelente dispositivo para transporte de vítimas com indicação de RMC, dispensando o uso de prancha rígida na maioria dos casos.

LIÇÃO 12 – ÂNGULO ZERO E AUTOEXTRICAÇÃO A técnica de ângulo zero visa minimizar a movimentação da coluna durante a extricação veicular. Estudos biomecânicos demonstram que a autoextricação assistida pode gerar menos movimento vertebral que o uso do KED.

TIPOS DE EXTRAÇÃO NO SALVAMENTO VEICULAR

Autor: Rubens Montalvão

IMEDIATA	Há risco imediato à vida da vítima, em razão do seu estado clínico ou da presença de ameaças, fazendo com que ela precise estar imediatamente fora do veículo. Prioriza-se a manutenção da vida em detrimento de possíveis lesões. Deve-se primar por um tempo total de atendimento curto, com mínimas intervenções no veículo.
RÁPIDA	O estado clínico da vítima é crítico ou está deteriorando. Deve-se dar prioridade para as necessidades médicas, obtendo-se, com o mínimo de ações sobre o veículo, o máximo de espaço interno e uma via de extração com espaço suficiente para a retirada da vítima. Há que se realizar uma intervenção limitada na vítima, com foco na avaliação primária. A avaliação secundária será feita se o tempo permitir e uma vez que as condições de risco à vida forem tratadas. É essencial que a vítima seja retirada do veículo dentro de 10 minutos.
CONTROLADA	Para vítima estável. Deve-se primar por um manuseio suave da vítima e a minimização da sua movimentação. Há que se atentar para a manutenção do seu alinhamento, retirando-a, preferencialmente, conforme o eixo no qual se encontra, evitando-se, rotações da coluna e da pélvis. Tem-se que criar o máximo espaço interno, em torno da vítima, e externo. Deve haver avaliação secundária e constante reavaliação. Quanto ao tempo total de atendimento, considera-se que 20 minutos é um objetivo atingível.
AUTOEXTRAÇÃO ASSISTIDA	Para vítima estável. A vítima consciente não encarcerada, mediante orientação do profissional de pré-hospitalar, sai do interior do veículo por seus próprios meios. A vítima deve estar sentada no interior do veículo, calma, sóbria, atenta, ser cooperativa, compreender o que é dito e não possuir lesões que inibam a sua capacidade de autoextração.

Exercícios de Fixação : Atualização em Atendimento Pré-Hospitalar

Qual foi a principal mudança introduzida pelo conceito XABCDE no atendimento ao trauma?

A) Priorizar a avaliação neurológica antes da via aérea

B) Priorizar o controle de hemorragias exsanguinantes antes da via aérea

C) Priorizar a imobilização da coluna antes de qualquer intervenção

D) Priorizar a ventilação antes do controle de hemorragias

Gabarito: B

Explicação: O conceito XABCDE introduz o controle imediato das hemorragias exsanguinantes (X – eXsanguination) antes mesmo da avaliação da via aérea, pois sangramentos maciços podem levar o paciente à morte em poucos minutos.

Qual é o ritmo recomendado de compressões durante a RCP no protocolo do CBMGO?

A) 60 a 80 compressões por minuto

B) 80 a 100 compressões por minuto

C) 100 a 120 compressões por minuto

D) 120 a 140 compressões por minuto

Gabarito: C

Explicação: O protocolo de RCP recomenda compressões torácicas entre 100 e 120 por minuto, garantindo perfusão cerebral e coronariana adequadas.

Qual é a conduta inicial específica para parada cardiorrespiratória por afogamento?

A) Iniciar imediatamente compressões torácicas

B) Aplicar torniquete preventivo

C) Iniciar com cinco ventilações utilizando AMBU com reservatório

D) Realizar desfibrilação imediata

Gabarito: C

Explicação: Na PCR por afogamento, a causa primária é hipóxia. Por isso, inicia-se o atendimento com cinco ventilações de resgate antes das compressões.

Em um paciente adulto com frequência respiratória entre 20 e 30 movimentos por minuto, qual é a conduta de oxigenoterapia indicada?

A) Não administrar oxigênio

B) Oxigênio por cateter nasal

C) Oxigênio por máscara com reservatório

D) Ventilação com AMBU imediatamente

Gabarito: C

Explicação: Pacientes com taquipneia devem receber oxigênio por máscara com reservatório, garantindo maior oferta de oxigênio ao organismo.

QUIZ 02 – FIXAÇÃO DO TEMA II

Restrição de Movimento da Coluna (RMC)

O que motivou a mudança do conceito de imobilização universal para restrição de movimento da coluna?

A) Falta de equipamentos nas ambulâncias

B) Evidências científicas demonstrando excesso de imobilizações desnecessárias

C) Aumento das fraturas cervicais no APH

D) Redução do tempo de transporte das vítimas

Gabarito: B

Explicação: Estudos como NEXUS e Canadian C-Spine Rule demonstraram que muitos pacientes eram submetidos a imobilizações sem necessidade clínica.

O que caracteriza o conceito de princípio no atendimento pré-hospitalar?

A) Técnica escolhida pelo socorrista

B) Procedimento definido pelo hospital

C) Fundamento científico universal voltado à melhora do paciente

D) Preferência individual do profissional

Gabarito: C

Explicação: Princípios são fundamentos científicos universais que orientam o atendimento, independentemente do método utilizado.

Em qual situação a restrição de movimento da coluna geralmente não é recomendada?

A) Trauma contuso com dor cervical

B) Trauma penetrante sem déficit neurológico

C) Acidente automobilístico com vítima inconsciente

D) Queda de altura com suspeita de trauma vertebral

Gabarito: B

Explicação: Em traumas penetrantes sem sinais neurológicos, a restrição pode atrasar o transporte e não apresenta benefício comprovado.

QUIZ 03 – FIXAÇÃO DO TEMA III

Dispositivos de Restrição de Movimento da Coluna

Qual é a principal vantagem da prancha scoop?

A) Permitir transporte prolongado da vítima

B) Possibilitar retirada da vítima sem rolamento lateral

C) Substituir a maca da ambulância

D) Ser utilizada apenas em vítimas inconscientes

Gabarito: B

Explicação: A prancha scoop permite remover a vítima sem realizar rolamento, reduzindo a movimentação da coluna vertebral.

Em qual situação a maca a vácuo é preferencialmente indicada?

A) Transporte rápido de vítima instável

B) Transporte prolongado de vítima estável

C) Extricação veicular emergencial

D) Parada cardiorrespiratória

Gabarito: B

Explicação: A maca a vácuo oferece maior conforto e suporte anatômico, sendo ideal para transporte de vítimas estáveis.

Qual é o objetivo da técnica de ângulo zero na extricação veicular?

A) Imobilizar completamente a coluna cervical

B) Minimizar a movimentação da coluna durante a retirada da vítima

C) Aumentar a velocidade da retirada da vítima

D) Facilitar o uso da prancha longa

Gabarito: B

Explicação: A técnica de ângulo zero busca reduzir ao máximo a movimentação da coluna durante a extricação.

TEMA – VÍTIMAS PSIQUIÁTRICAS E TENTATIVA DE AUTOEXTERMÍNIO

APRESENTAÇÃO DO TEMA

As ocorrências envolvendo vítimas psiquiátricas e situações de tentativa de autoextermínio representam um desafio significativo para as equipes de atendimento pré-hospitalar. Essas situações podem envolver alterações importantes do comportamento, sofrimento psíquico intenso, impulsividade, desorganização emocional e risco de autoagressão ou agressão a terceiros. No contexto operacional do Corpo de Bombeiros Militar, é fundamental que os profissionais estejam preparados para reconhecer sinais de sofrimento mental agudo e adotar estratégias de abordagem que priorizem a segurança da equipe, da vítima e das pessoas presentes no local.

No ambiente pré-hospitalar, as vítimas psiquiátricas podem apresentar diferentes manifestações comportamentais, que variam desde estados de ansiedade intensa e desorganização emocional até episódios de agitação, agressividade ou comportamento autodestrutivo. Esses quadros podem estar associados a transtornos psiquiátricos, uso ou abstinência de substâncias psicoativas, alterações metabólicas, doenças neurológicas ou situações de estresse psicológico extremo. Diante dessas circunstâncias, a equipe de resgate deve realizar uma avaliação cuidadosa do cenário e do estado clínico do paciente, adotando medidas que permitam conduzir o atendimento de forma segura, ética e humanizada.

A abordagem adequada dessas ocorrências envolve múltiplos aspectos, incluindo avaliação clínica inicial, controle do ambiente, comunicação eficaz com a vítima, identificação de riscos e, quando necessário, adoção de medidas de contenção e suporte médico. Em todas as situações, a prioridade deve ser preservar a vida, reduzir riscos e garantir a segurança de todos os envolvidos na ocorrência.

LIÇÃO 01 – CONCEITO DE VÍTIMAS PSIQUIÁTRICAS NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

No contexto do atendimento pré-hospitalar, considera-se vítima psiquiátrica o indivíduo que apresenta alterações significativas do comportamento, da percepção ou do estado emocional, capazes de comprometer sua capacidade de julgamento, autocontrole ou interação com o ambiente. Essas alterações podem se manifestar por meio de inquietação intensa, impulsividade, irritabilidade, comportamento agressivo, desorganização do pensamento ou ideação suicida.

Em situações de tentativa de autoextermínio, o paciente pode demonstrar comportamento autodestrutivo ou verbalizar desejo de morrer, exigindo intervenção rápida e cuidadosa por parte da equipe de atendimento. Esses episódios podem variar desde manifestações leves de sofrimento psíquico até situações graves que representem risco iminente à vida do paciente ou de outras pessoas presentes no local.

No ambiente operacional do atendimento pré-hospitalar, reconhecer precocemente esses sinais é fundamental para evitar a escalada da situação e permitir a adoção de estratégias adequadas de manejo e proteção.

LIÇÃO 02 – FISIOPATOLOGIA E ALTERAÇÕES NEUROQUÍMICAS

As alterações comportamentais observadas em vítimas psiquiátricas estão frequentemente associadas a desequilíbrios neuroquímicos no sistema nervoso central. Diversos neurotransmissores desempenham papel importante na regulação das emoções, do comportamento e do controle dos impulsos, entre eles a dopamina, a serotonina e a noradrenalina.

Alterações nesses sistemas podem provocar desregulação emocional, aumento da impulsividade, alterações da percepção da realidade e dificuldade de controle comportamental. Essas mudanças podem ocorrer em decorrência de transtornos

psiquiátricos primários, intoxicação por substâncias psicoativas, abstinência de álcool ou drogas, distúrbios metabólicos ou lesões neurológicas.

Por essa razão, a avaliação do paciente deve considerar não apenas o comportamento apresentado no momento da ocorrência, mas também possíveis causas clínicas que possam estar contribuindo para o quadro apresentado.

LIÇÃO 03 – PRINCIPAIS CAUSAS

As ocorrências envolvendo vítimas psiquiátricas e tentativa de autoextermínio podem ter diferentes origens. Entre as causas mais comuns estão os transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, transtornos de humor, episódios depressivos graves e transtornos de personalidade. Nessas situações, o paciente pode apresentar alteração significativa da percepção da realidade, impulsividade ou ideação suicida.

Além das causas psiquiátricas, diversas condições clínicas também podem provocar alterações comportamentais semelhantes, incluindo hipóxia, hipoglicemia, traumatismo cranioencefálico, infecções sistêmicas e distúrbios metabólicos. O uso de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, anfetaminas e drogas sintéticas, também pode desencadear alterações importantes do comportamento. Da mesma forma, o processo de abstinência dessas substâncias pode gerar agitação, ansiedade intensa e comportamento agressivo.

A identificação da causa provável do quadro é um elemento importante para orientar a condução do atendimento e determinar as medidas mais adequadas para a estabilização do paciente.

LIÇÃO 04 – AVALIAÇÃO INICIAL

A avaliação inicial de uma ocorrência envolvendo vítima psiquiátrica deve priorizar, antes de qualquer intervenção direta, a segurança da equipe de resgate, da própria vítima e de terceiros presentes no local. A análise do cenário permite identificar possíveis riscos e definir a melhor estratégia de abordagem.

Após garantir condições mínimas de segurança, a equipe deve realizar avaliação clínica básica do paciente, observando nível de consciência, presença de lesões traumáticas, sinais vitais, possíveis sinais de intoxicação e informações relevantes sobre histórico médico conhecido. Sempre que possível, deve-se buscar informações adicionais com familiares, testemunhas ou pessoas presentes no local da ocorrência.

Mesmo diante de relatos fornecidos por terceiros, é fundamental que a equipe realize sua própria avaliação sistematizada do paciente, utilizando protocolos de avaliação clínica como a análise da ACENA, que permite identificar alterações relevantes no estado geral da vítima.

A abordagem deve ser realizada de maneira calma, respeitosa e estratégica, evitando atitudes que possam aumentar a tensão emocional do paciente ou provocar reações agressivas.

LIÇÃO 05 – ABORDAGEM VERBAL

A comunicação verbal constitui uma das principais ferramentas no manejo de ocorrências envolvendo vítimas psiquiátricas ou tentativa de autoextermínio. Uma abordagem adequada pode contribuir significativamente para reduzir o nível de tensão da situação e facilitar a cooperação do paciente.

Durante o contato com a vítima, os profissionais devem manter tom de voz calmo, postura tranquila e linguagem clara. Frases curtas e objetivas tendem a facilitar a compreensão do paciente, especialmente em situações de sofrimento emocional intenso. Demonstrar empatia, ouvir atentamente o que o paciente tem a dizer e evitar confrontos diretos são estratégias importantes para estabelecer vínculo e reduzir a possibilidade de comportamento agressivo.

A manutenção de uma distância segura também é recomendada, permitindo que a equipe preserve sua segurança sem transmitir sensação de ameaça ao paciente.

LIÇÃO 06 – CONTENÇÃO FÍSICA

Em determinadas situações, quando o paciente apresenta risco imediato de autoagressão ou agressão a terceiros, pode ser necessária a utilização de técnicas de contenção física. Esse procedimento deve ser realizado de maneira criteriosa e somente quando outras estratégias de abordagem não forem suficientes para garantir a segurança da ocorrência.

A contenção deve ser realizada preferencialmente por mais de um profissional, permitindo o controle simultâneo dos membros superiores e inferiores do paciente. Durante todo o procedimento, deve-se garantir a proteção das vias aéreas e manter monitorização constante das condições clínicas da vítima.

É importante destacar que a contenção física deve ser utilizada apenas pelo tempo necessário para garantir a segurança da situação, devendo sempre estar associada à avaliação clínica contínua e ao encaminhamento do paciente para avaliação médica especializada.

LIÇÃO 07 – MANEJO FARMACOLÓGICO

Em alguns casos de vítimas psiquiátricas com comportamento extremamente agitado ou com risco elevado de autoagressão, pode ser necessário o uso de sedação farmacológica para controle do quadro. Os medicamentos mais frequentemente utilizados nesse contexto incluem benzodiazepínicos e antipsicóticos, que atuam na redução da ansiedade, da impulsividade e da agitação.

A administração desses medicamentos deve seguir protocolos médicos específicos e considerar fatores como idade do paciente, condições clínicas associadas e possíveis riscos de efeitos adversos. Sempre que possível, o uso de sedação deve ser realizado sob orientação médica e associado à monitorização contínua do paciente.

LIÇÃO 08 – SEGURANÇA OPERACIONAL

A segurança da equipe de atendimento deve ser considerada prioridade absoluta em ocorrências envolvendo vítimas psiquiátricas ou tentativa de autoextermínio. Antes de iniciar qualquer intervenção, é necessário avaliar cuidadosamente o ambiente, identificando objetos que possam ser utilizados como armas ou que representem risco para os profissionais de resgate.

O posicionamento estratégico da equipe, a comunicação constante entre os profissionais e a observação contínua do comportamento do paciente são medidas fundamentais para garantir a segurança da operação. Em determinadas situações, especialmente quando há risco elevado de agressividade ou violência, pode ser necessária a solicitação de apoio policial para garantir o controle do cenário e permitir a realização do atendimento de forma segura.

A	Avaliar **arredores**, a casa e a presença de **armas ou artefatos** que indiquem o uso de álcool e drogas; altura e a aparência da vítima.
C	Observar a presença de sinais de **conflito e crise** na rede social da vítima.
E	Avaliar as **expectativas** e a receptividade da rede social, da própria vítima e da equipe de atendimento.
N	Avaliar o **nível de consciência**, a adequação à realidade, a capacidade de escolha e o **nível de sofrimento**.
A	Avaliar a presença de sinais de uso de **álcool e drogas**, a presença de **agressividade** (atual ou anterior) e a presença de sinais de **autoagressão**.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Questão 1

As vítimas psiquiátricas podem ser definidas como:

A) Redução da atividade motora associada à sonolência profunda.
B) Estado caracterizado por aumento da atividade motora associado a alterações comportamentais e emocionais.
C) Condição clínica caracterizada exclusivamente por perda da consciência.
D) Alteração neurológica restrita a pacientes psiquiátricos.

Gabarito: B

Questão 2

Entre as possíveis causas clínicas da agitação psicomotora, pode-se citar:

A) Hipoglicemia e hipóxia.
B) Apenas transtornos psiquiátricos.
C) Exclusivamente intoxicação alcoólica.
D) Apenas distúrbios neurológicos degenerativos.

Gabarito: A

Questão 3

Durante a abordagem inicial do paciente com agitação psicomotora, a prioridade da equipe de atendimento deve ser:

A) Administração imediata de medicação sedativa.
B) Coleta detalhada do histórico psiquiátrico.
C) Garantir a segurança da equipe, da vítima e de terceiros.
D) Realizar imobilização física imediata do paciente.

Gabarito: C

Questão 4

A abordagem verbal no manejo do paciente agitado tem como objetivo principal:

A) Provocar resposta emocional no paciente.
B) Reduzir o nível de agitação e estabelecer comunicação.
C) Demonstrar autoridade da equipe de atendimento.
D) Substituir completamente a avaliação clínica.

Gabarito: B

Questão 5

A contenção física do paciente agitado deve ser realizada:

A) Sempre que o paciente apresentar comportamento inquieto.
B) Apenas quando houver risco imediato para o paciente ou para terceiros.
C) Como primeira estratégia de abordagem.
D) Exclusivamente por um único profissional.

Gabarito: B

Questão 6

Entre os medicamentos frequentemente utilizados no manejo farmacológico da agitação psicomotora estão:

A) Antibióticos e anti-inflamatórios.
B) Benzodiazepínicos e antipsicóticos.
C) Analgésicos simples.
D) Antialérgicos.

Gabarito: B

Questão 7

No contexto do atendimento pré-hospitalar, a presença de agitação psicomotora pode estar associada a:

A) Intoxicação por substâncias psicoativas.
B) Distúrbios metabólicos.
C) Lesões neurológicas.
D) Todas as alternativas anteriores.

Gabarito: D

Questão 8

A avaliação inicial do paciente agitado deve incluir:

A) Apenas avaliação psiquiátrica.
B) Verificação de sinais vitais e nível de consciência.
C) Apenas investigação social.
D) Apenas avaliação comportamental.

Gabarito: B

Questão 9

Entre os princípios da comunicação com paciente agitado, destaca-se:

A) Utilizar tom de voz elevado.
B) Confrontar diretamente o paciente.
C) Manter comunicação calma e clara.
D) Ignorar as falas do paciente.

Gabarito: C

Questão 10

A segurança operacional durante o atendimento a pacientes agitados envolve:

A) Avaliação do ambiente e identificação de riscos.
B) Posicionamento estratégico da equipe.
C) Comunicação entre os profissionais.
D) Todas as alternativas anteriores.

Gabarito:D

APH em ÁREA REMOTA

LIÇÃO 1 – CONCEITO DE ÁREA REMOTA

No contexto do Atendimento Pré-Hospitalar, considera-se área remota qualquer ambiente em que o acesso aos serviços de saúde seja limitado ou em que o tempo necessário para transporte da vítima até uma unidade hospitalar seja significativamente prolongado. Esse tipo de cenário pode ocorrer em áreas rurais afastadas, regiões de difícil acesso geográfico, ambientes de montanha, florestas, áreas alagadas, rios ou lagos, entre outros locais onde as condições de deslocamento e comunicação são restritas.

A principal característica dessas ocorrências é a impossibilidade de acesso rápido ao tratamento definitivo. Dessa forma, as equipes de resgate devem estar preparadas para prestar assistência por períodos mais prolongados, garantindo a estabilização da vítima até que seja possível realizar sua evacuação com segurança.

LIÇÃO 2 – DESAFIOS OPERACIONAIS NO ATENDIMENTO EM ÁREAS REMOTAS

O atendimento em áreas remotas apresenta uma série de desafios operacionais que exigem preparo técnico e planejamento por parte das equipes de resgate. Entre esses desafios destacam-se as dificuldades de acesso ao local da ocorrência, que podem envolver longas distâncias, terrenos acidentados ou ausência de vias de transporte adequadas.

Outro fator relevante é a limitação de recursos disponíveis no local da ocorrência. Em muitas situações, a equipe dispõe apenas dos equipamentos transportados durante o deslocamento, sendo necessário utilizar os recursos de forma racional e estratégica. Além disso, as condições ambientais, como variações climáticas, baixa visibilidade ou presença de obstáculos naturais, podem interferir diretamente na execução do atendimento e na segurança dos profissionais envolvidos.

Figura 21-2 O atendimento ao paciente em uma caverna representa inquestionavelmente o EMS selvagem.

Figura 21-4 Encostas íngremes, penhascos, quedas de rochas e pisos irregulares são perigosos no resgate em áreas selvagens.

LIÇÃO 3 – AVALIAÇÃO DO CENÁRIO

Antes de iniciar qualquer intervenção junto à vítima, a equipe deve realizar uma avaliação cuidadosa do cenário da ocorrência. Essa análise inicial tem como objetivo identificar possíveis riscos para os profissionais de resgate e para a própria vítima. A segurança da equipe deve ser sempre considerada prioridade, uma vez que a ocorrência de novos acidentes pode comprometer toda a operação de resgate.

Durante a avaliação do cenário devem ser observados fatores como estabilidade do terreno, condições climáticas, presença de animais, risco de quedas ou deslizamentos, além da possibilidade de acesso e evacuação do paciente.

Somente após essa avaliação inicial é que a equipe deve iniciar o atendimento direto à vítima.

LIÇÃO 4 – AVALIAÇÃO DO PACIENTE

A avaliação do paciente em áreas remotas segue os mesmos princípios fundamentais do Atendimento Pré-Hospitalar tradicional. Inicialmente deve-se realizar a avaliação primária, com foco na identificação de condições que representem risco imediato à vida. Essa avaliação inclui análise do nível de consciência, verificação da permeabilidade das vias aéreas, avaliação da respiração e da circulação, além da identificação de possíveis hemorragias graves.

Após a estabilização das condições críticas, deve-se proceder à avaliação secundária, que consiste em exame físico mais detalhado e coleta de informações adicionais sobre o estado clínico da vítima. Em áreas remotas, essa avaliação deve ser ainda mais criteriosa, considerando que o transporte até uma unidade hospitalar pode levar um tempo considerável.

LIÇÃO 5 – MANEJO PROLONGADO DO PACIENTE

Em situações nas quais o tempo de evacuação é prolongado, a equipe de atendimento precisa manter cuidados contínuos com o paciente. Esse processo envolve monitorização constante dos sinais vitais, reavaliação periódica das condições clínicas e adoção de medidas que contribuam para a manutenção da estabilidade do quadro da vítima.

Entre os cuidados mais importantes estão o controle da dor, a prevenção de hipotermia, a manutenção de hidratação adequada e a observação contínua de possíveis alterações no estado de consciência. Esse tipo de assistência é conhecido como cuidado prolongado no ambiente pré-hospitalar e constitui um dos principais desafios do atendimento em áreas remotas.

LIÇÃO 6 – EVACUAÇÃO E TRANSPORTE

A evacuação da vítima em ambientes remotos deve ser cuidadosamente planejada, levando em consideração as condições do terreno, o estado clínico do paciente e os recursos disponíveis. Dependendo das características da ocorrência, podem ser utilizadas diferentes estratégias de transporte, incluindo deslocamento manual, uso de macas específicas para resgate, transporte terrestre ou apoio aéreo quando disponível.

Figura 21-11 Um paciente embalado em um colchão a vácuo em posição lateral para obter imobilização fisiológica e ajudar a manter as vias aéreas abertas.

A escolha do método de evacuação deve sempre priorizar a segurança da equipe e da vítima, além de buscar a forma mais rápida e eficiente de encaminhamento para unidade de saúde adequada.

Figura 21-8 Uma maca com rodas está sendo usada para transportar um paciente ferido após um acidente de mountain bike. Embora seja mais fácil do que transportar diretamente um paciente que não consegue andar, ainda requer recursos consideráveis.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Questão1

No contexto do Atendimento Pré-Hospitalar, considera-se área remota aquela em que:

A) há grande disponibilidade de recursos hospitalares.
B) existe acesso imediato a unidades de saúde.
C) o acesso aos serviços de saúde é limitado ou demorado.
D) o atendimento ocorre exclusivamente em áreas urbanas.

Gabarito: C

Questão2

Um dos principais desafios do atendimento em áreas remotas é:

A) excesso de recursos disponíveis.
B) facilidade de acesso ao local da ocorrência.
C) limitação de equipamentos e dificuldade de transporte.
D) proximidade de unidades hospitalares.

Gabarito: C

Questão3

Antes de iniciar o atendimento à vítima, a equipe deve priorizar:

A) a avaliação da segurança do cenário.
B) a administração imediata de medicamentos.
C) o transporte rápido da vítima.
D) a coleta de dados administrativos.

Gabarito: A

Questão4
No atendimento em áreas remotas, o manejo prolongado do paciente pode incluir:

A) monitorização contínua e prevenção de hipotermia.
B) apenas transporte imediato.
C) interrupção da avaliação clínica.
D) ausência de reavaliação do paciente.

Gabarito: A

Questão5
A escolha da forma de evacuação da vítima deve considerar principalmente:

A) a preferência da equipe.
B) a segurança da equipe e as condições da vítima.
C) apenas a distância do hospital.
D) exclusivamente a disponibilidade de veículos.

Gabarito: B